Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
4ª Vara Cível (Especializada em Fazenda Pública) da Comarca de Novo Hamburgo

Rua Bayard Toledo Mércio, 66, 7º andar - Bairro: Canudos - CEP: 93548011 - Fone: 51 99744-1336 - Balcão virtual via WhatsApp - Email: frnovohamb4vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5019672-50.2024.8.21.0019/RS

AUTOR: LECI JANDIRA ENGEL

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

LECI JANDIRA ENGEL ajuizou ação de rito ordinário, com pedido de tutela antecipada, em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, objetivando o fornecimento do fármaco RIBOCICLIBE 200MG, em razão do seu diagnóstico de Neoplasia Maligna de Mama. Disse que não obteve êxito no fornecimento do fármaco na esfera administrativa. Requereu, liminarmente, o fornecimento do medicamento. No mérito, a confirmação da medida de urgência.

Deferida a tutela liminar.

Apresenta nota tecnica favorável pelo NATJUS.

Devidamente citado, o ESTADO apresentou contestação. (90.1).

Houve réplica.

MP maniofestou-se nos autos pela procedência da pretensão deduzida na inicial, com a confirmação da liminar concedida.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Passo a fundamentar.

1. Das Preliminares.

1.1 Da competência em razão da matéria.

A questão da competência está superada pela tese fixada no RE 1.366.243/SC, Repercussão Geral - Tema 1234, publicado em 19/09/2024. Segue o trecho do voto relativo à competência, com redação alterada após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina:

> *I - Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.*

No ponto, houve a modulação de efeitos para aplicação aos processos ajuizados após a publicação do julgamento no DJE, que ocorreu em 19/09/2024:

> *Por fim, modulo os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), propondo que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.*

Ainda sobre a competência, o Ministro Relator, no voto vencedor, que acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos pela União, definiu:

> *3) acolho parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. C**onsequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco,** sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.*

No caso, o ajuizamento do processo ocorreu em 05/08/2024 e o(s) fármaco(s) postulado(s) não é(são) incorporado(s) ao SUS.

Assim, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual.

1.2 Da responsabilidade pelo fornecimento do medicamento.

O Estado do Rio Grande do Sul arguiu em contestação a aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento do Tema 793 do STF, com consequente inclusão da União no polo passivo (evento 90.1).

De maneira explícita, no voto relator no RE 1.366.243/SC, o Min. Gilmar Mendes definiu:

> *Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva,* ***esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.*** *(Grifos no original)*[1]

Já no que tange à responsabilidade pelo fornecimento do **medicamento incorporado**, a tese definida no Tema 1234 do STF, que homologou os 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos), consolidou a obrigatoriedade do Poder Judiciário observar a divisão e os fluxos administrativos:

> *4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra:*
>
> *(...)*
> *Atuação do Poder Judiciário na íntegra do item 4.1: O(a) juiz(a) deverá analisar, à luz do controle de legalidade, qual a fase do fluxo de distribuição do medicamento, especificamente do caso dos autos, determinando o fornecimento em face de qual ente público deve fornecêlo.*

No caso dos medicamentos **não incorporados**, definiu-se:

> *3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.*

Não houve modulação de efeitos no ponto, razão pela qual a aplicabilidade é imediata.

Portanto, tratando-se de medicamentos não incorporados ao SUS, a responsabilidade pelo fornecimento, em ação judicial, é do Estado do Rio Grande do Sul, resguardado o direito de ressarcimento de forma administrativa, nos termos do Tema 1234 do STF.

2. Do mérito

2.1 Da Assistência à Saúde e Jurisprudência aplicável

A Constituição Federal, em seu art. 5º, caput, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado. A Lei 8.080/90, em seu art. 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS – Sistema Único de Saúde - e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, a se ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o dever do Estado, lato sensu considerado, ou seja, modo indistinto por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 23, II e 196, ambos da Constituição Federal.

O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade.

Recentemente, com o julgamento dos Temas 1234 e 06, o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas Vinculantes 60 e 61, atinentes à disponibilização de medicamentos:

Súmula vinculante 60

Enunciado

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)."

Súmula vinculante 61

Enunciado

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

De acordo com a tese fixada no Tema 1234 do STF, ficou determinado que:

"[...] O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados como as teses fixadas no presente tema da sistemática da repercussão geral, a saber:

(...)

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(...)

IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

(...)

VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão" [...]" (grifei).

Por sua vez, o Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), fixou parâmetros para apreciação de pedidos de medicamentos não incorporados:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas ***não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde****, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:* ***(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa****, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b)* ***ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação,*** *tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c)* ***impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;*** *(d)* ***comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;*** *(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante* ***laudo médico fundamentado,*** *descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f)* ***incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.*** *3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2,* ***a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)****, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco,* ***oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.*** *Grifou-se.*

No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.366.243/SC, o Min. Gilmar Mendes esclareceu:

Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024).

Assim, nos termos do art. 987, §2º, do CPC, a tese jurídica fixada pelo STF tem aplicação imediata, independentemente de trânsito em julgado. E os efeitos modulatórios da decisão, no caso, foram estabelecidos somente no que respeita à regra de competência.

2.2 Da prova da moléstia, da ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS e da necessidade do tratamento postulado.

A prestação jurisdicional, todavia, não pode deixar de considerar a situação individualizada de cada caso.

Em análise objetiva, o medicamento postulado nesta ação possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não está incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento do diagnóstico apresentado pela parte autora. Ainda, não há análise de pedido de incorporação pela Conitec.

No presente feito, o laudo médico juntado atesta que a parte autora é portadora de Neoplasia maligna da mama (CID 10:C50,9) e necessita fazer uso do medicamento postulado, pois possui risco de progressão de doença e morte, (evento 1.8).

Ademais, o laudo médico indica os estudos científicos que comprovam a eficácia do medicamento para o caso da autora (evento 1.8).

No mesmo sentido, após consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sobreveio Nota Técnica favorável ao fornecimento do medicamento (evento 22.1):

> ***CONCLUSÃO***
>
> ***Tecnologia:*** *SUCCINATO DE RIBOCICLIBE*
>
> ***Conclusão Justificada:*** *Favorável*
>
> ***Conclusão:*** *CONSIDERANDO o diagnóstico de neoplasia maligna da mama metastática CONSIDERANDO solicitação de associação de Ribociclib a Anastrozol (este fornecido pelo SUS e já utilizado pela paciente) CONSIDERANDO eficácia comprovada do tratamento e parecer favorável da CONITEC CONCLUI-SE que há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação pleiteada em regime de urgência*
>
> ***Há evidências científicas?*** *Sim*
>
> ***Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?*** *Sim*
>
> ***Justificativa:*** *Com risco potencial de vida*
>
> ***Referências bibliográficas:*** *INCA: Estimativa 2018 - Incidência de câncer no Brasil. 2018 Hortobagyi GN, Stemmer SM, et al. Overall Survival with Ribociclib plus Letrozole in Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2022 Mar 10;386(10):942- 950. doi: 10.1056/NEJMoa2114663. PMID: 35263519 CONITEC - Abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe para o tratamento de pacientes adultas com câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2- Relatório 678 / 2021. https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2021/20211207_relatorio_678_ab emaciclibe_palbociclibe_ribociclibe_carcinoma_mama_final.pdf Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Câncer de Mama. Fevereiro/2024. Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/ptbr/midias/consultas/relatorios/2024/RRPCDTCncerdeMama_CP.pdf Hortobagyi GN, Stemmer SM, et al. Updated results from MONALEESA-2, a phase III trial of first-line ribociclib plus letrozole versus placebo plus letrozole in hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer. Ann Oncol. 2018 Jul 1;29(7):1541-1547. doi: 10.1093/annonc/mdy155. Erratum in: Ann Oncol. 2019 Nov 1;30(11):1842. PMID: 29718092.*
>
> ***NatJus Responsável:*** *Nacional Instituição*
>
> ***Responsável:*** *Hospital Israelita Albert Einstein*
>
> *[..]*

A parte autora comprovou a negativa administrativa do demandado (evento 14), bem como a incapacidade financeira de custear o tratamento (evento 14.9), razão pela qual foi deferida a antecipação da tutela.

Assim, diante das alegações médicas, entendo que a não concessão da medicação postulada atentaria diretamente contra o direito constitucionalmente garantido à saúde, enquanto, devido a impedimentos de ordem administrativa, a parte autora teria prejudicada de forma considerável a possibilidade de diminuição dos efeitos decorrentes de sua enfermidade.

Diante disso, resta evidente a necessidade da parte autora em receber o tratamento pleiteado, haja vista que é indispensável à manutenção de sua saúde. Dessa forma, assegurado o direito da parte autora em ter a sua saúde resguardada e comprovada a necessidade que possui em receber os medicamentos, tenho que é o caso de confirmação da antecipação de tutela deferida.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **LECI JANDIRA ENGEL**, contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, para tornar definitivos os efeitos da tutela antecipada deferida, observada a Denominação Comum Brasileira.

A prescrição médica deverá ser atualizada semestralmente, salvo se outra periodicidade for estabelecida administrativamente, junto ao ponto de distribuição de medicamentos da Secretaria de Estado da Saúde – Farmácia de Medicamentos Especiais ou outro local – pois há necessidade de acompanhamento do tratamento para verificação do uso efetivo e do resultado apresentado. A não atualização do receituário acarretará a suspensão do fornecimento pela Farmácia do Estado até que ocorra a regularização e impedirá a apreciação de eventual pedido de bloqueio de valores.

Ficam cientes das partes, que em caso de descumprimento da presente decisão, para aquisição o valor de venda do medicamento será limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação CNJ nº 146/2023. Sob nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG (Item VI, p.73 do RE n. 1366243 / SC).

Em cumprimento ao disposto no Tema 06 do STF, oficie-se ao Ministério da Saúde (https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documento-junto-ao-ministerio-da-saude), informando acerca do deferimento judicial do medicamento RIBOCICLIBE 200MG, para tratamento de Neoplasia Maligna de Mama, a fim de que seja avaliada a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Sem custas e honorários de advogado, nos termos do art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95.

OBSERVAÇÃO. Em caso de remessa dos autos à Instância Recursal (recurso voluntário ou remessa oficial), e havendo necessidade do cumprimento provisório da decisão, ajuizar procedimento de cumprimento provisório de sentença por dependência ao presente feito. Motivo: enquanto tramitar em outra instância ou em fase recursal, este juízo fica impedido de acessar para decidir nos autos eletrônicos originais do sistema E-PROC.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Intimações eletrônicas agendadas e publicações em registros eletrônicos.

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL PELLEGRINO KREDENS, Juiz de Direito**, em 03/11/2025, às 15:53:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10094312368v5** e o código CRC **ce6de65a**.

---

1. Voto Relator no RE 1.366.243/SC, pág. 96 ↩